

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Cuestionario Disejecutivo, versión española (Dysexecutive Questionnaire) (DEX-Sp)

Eje V • Versión de trabajo: 10 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1. Identificación

Familia / sigla	DEX-Sp
Nombre completo	Cuestionario Disejecutivo, versión española (Dysexecutive Questionnaire)
Versión / edición	Adaptación/versión española (autoinforme, 20 ítems) del Dysexecutive Questionnaire (DEX) original, integrado en la batería BADS (Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome).
Idioma	Español (España).
Autores (original)	Wilson, B. A., Alderman, N., Burgess, P. W., Emslie, H., & Evans, J. J. (autores originales, BADS/DEX). Adaptación española: Pedrero-Pérez, E. J. y colaboradores.
Año (original / adaptación)	1996 (original, Thames Valley Test Company); adaptación/validación española 2009-2011 (Pedrero-Pérez et al.).

2. Eje y pregunta clínica

Eje primario	Eje V — Funcionamiento cognitivo y neuropsicológico
Etiquetas	Funciones ejecutivas; disfunción ejecutiva conductual; autoinforme; cribado neuropsicológico ecológico.
Pregunta clínica que responde	¿Hay variables cognitivas para explorar o derivar?

3. Constructo, finalidad y usos

Constructo evaluado: Síntomas disejecutivos conductuales autopercebidos en la vida cotidiana, agrupados en la versión española en dos dimensiones:

Desorganización/Apatía y Desinhibición/Impulsividad (Pedrero-Pérez et al., 2011).

Finalidad: Cribado autoinformado de disfunción ejecutiva conductual (síndrome disejecutivo), como complemento ecológico a pruebas de ejecución (p. ej. WCST, TMT, Stroop, BADS) que no siempre capturan el impacto funcional cotidiano de las alteraciones ejecutivas.

Usos apropiados:

- Cribado y exploración clínica o de investigación de síntomas disejecutivos percibidos por el propio sujeto.
- Seguimiento de cambios subjetivos en el funcionamiento ejecutivo (p. ej. en TCE, adicciones, otras condiciones neurológicas o psiquiátricas).
- Complemento a una batería neuropsicológica multimétodo; comparación potencial con versión de informante del DEX original (no incluida en este acervo).

Usos NO apropiados:

- Diagnóstico aislado de síndrome disejecutivo o de cualquier condición neurológica/psiquiátrica.
- Sustituto de pruebas de ejecución objetivas (BADS, WCST, TMT, Stroop, etc.).
- Uso en menores de edad sin adaptación y validación específica (no localizada en la búsqueda realizada).
- Decisiones legales, laborales o periciales basadas únicamente en este autoinforme, dado el riesgo de anosognosia en daño prefrontal.

4. Población, contexto, informante y modalidad

Población	Adultos (18+). Estudios de validación española en personas adictas a sustancias en tratamiento y en población general no clínica.
Contexto de aplicación	Clínico (neuropsicología, adicciones, rehabilitación), investigación.
Informante	Autoinforme (el DEX original incluye también una versión para informante/familiar, no incluida en este acervo).
Modalidad de administración	Papel y lápiz; autoadministrado o heteroadministrado con supervisión; individual.

5. Estructura y administración

Número de ítems	20 ítems (versión española validada por Pedrero-Pérez et al.).
Periodo temporal de referencia	No verificado — no se localizó un periodo de referencia temporal estandarizado explícito en las fuentes consultadas; el enunciado remite a comportamiento habitual/reciente. No usar para decisiones sin confirmar en la fuente primaria.
Formato de respuesta	Escala Likert de 5 puntos (1 = Nunca ... 5 = Muy frecuentemente), verificado directamente en Protocolo.pdf (corregido 2026-08-10; la versión previa indicaba erróneamente 0-4).
Tiempo estimado de aplicación	Aproximadamente 5-10 minutos (estimación editorial, no verificada en fuente primaria).

6. Dimensiones y puntuaciones

Estructura factorial de dos dimensiones reportada en población española (Pedrero-Pérez et al., 2011): Desorganización/Apatía e Desinhibición/Impulsividad. El análisis factorial exploratorio y confirmatorio ofrece soluciones de 4 y 5 factores según el estudio; la agrupación en 2 dimensiones amplias es la más citada para uso clínico resumido.

7. Sistema de puntuación

Regla de puntuación	Suma de las puntuaciones de los ítems (1-5 cada uno, según Protocolo.pdf) por dimensión y puntuación total.
Ítems invertidos	No verificado — no se localizaron ítems inversos documentados en las fuentes consultadas.
Ítems omitidos / reglas de omisión	No verificado — no se localizó una regla de manejo de omisiones en las fuentes consultadas.
Rango posible	20-100 (20 ítems × 1-5, según escala verificada en Protocolo.pdf).
Puntos de corte	No se localizaron puntos de corte clínicos de consenso en la búsqueda realizada — no verificado, no usar para decisiones diagnósticas.

8. Evidencia psicométrica en español / LatAm

Pedrero-Pérez, E. J. et al. (2009) evaluaron la sintomatología disejecutiva en adictos a sustancias en tratamiento mediante el DEX-Sp (revista Adicciones). Pedrero-Pérez, E. J. et al. (2011), en Revista de Neurología 52(7):394-404, reportaron datos normativos y propiedades psicométricas en muestra de población española, con consistencia interna alta (alfa de Cronbach ≈ 0.91 según fuentes secundarias consultadas) y estructura factorial de 2 dimensiones amplias. Los tamaños muestrales exactos no se verificaron con certeza en el texto completo (acceso restringido); tratar cifras como orientativas y confirmar contra el artículo original antes de su uso en investigación.

9. Adaptación cultural y norma local

Adaptación y validación en población española (Pedrero-Pérez et al.). No se localizaron normas específicas para Latinoamérica en la búsqueda realizada — no verificado.

10. Límites clínicos, seguridad, derivación y no-diagnóstico

- Es un instrumento de cribado subjetivo; sujeto a sesgos de introspección y a anosognosia, frecuente en daño prefrontal (motivo por el cual el DEX original incluye también una versión para informante).
- No sustituye una evaluación neuropsicológica objetiva ni el juicio clínico profesional.
- Ante sospecha de daño prefrontal, TCE u otra condición neurológica, derivar a neuropsicología/neurología para evaluación formal.
- No emplear como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Obtener consentimiento informado y proteger la confidencialidad de los resultados.

11. Titular, licencia y condiciones de reproducción

El DEX original (dentro de la batería BADS) fue publicado por Thames Valley Test Company (actualmente distribuido comercialmente, p. ej. por Pearson); su reproducción y uso comercial está sujeta a licencia del titular. La versión española (DEX-Sp) analizada aquí ha sido reproducida en artículos científicos (Adicciones; Revista de Neurología) con fines de investigación y difusión académica; el Protocolo.pdf de este acervo es un escaneo de un documento de circulación académica/clínica (ya presente en el acervo local del proyecto), identificado por OCR y contrastado con las fuentes citadas.

Verificar condiciones de reproducción con los titulares antes de cualquier uso comercial o redistribución masiva.

12. DOI / URL oficiales y referencias APA

Wilson, B. A., Alderman, N., Burgess, P. W., Emslie, H., & Evans, J. J. (1996). Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome (BADS). Thames Valley Test Company.

Pedrero-Pérez, E. J., Ruiz-Sánchez de León, J. M., Rojo-Mota, G., Llanero-Luque, M., Pedrero-Pérez, E., Morandé, G., & Puerta-García, C. (2009). Sintomatología disejcutiva en adictos a sustancias en tratamiento mediante la versión española del Cuestionario Disejcutivo (DEX-Sp). Adicciones. <https://adicciones.es/index.php/adicciones/article/view/243>

Pedrero-Pérez, E. J., et al. (2011). Evaluación de los síntomas prefrontales: propiedades psicométricas y datos normativos del cuestionario disejcutivo (DEX) en una muestra de población española. Revista de Neurología, 52(7), 394-404. <https://www.ucm.es/data/cont/docs/140-2013-10-04-documento25538.pdf>

Documento de referencia adicional (protocolo con anexo): [https://www.logicortex.com/wp-content/uploads/DEX%20\(Con%20Anexo\).pdf](https://www.logicortex.com/wp-content/uploads/DEX%20(Con%20Anexo).pdf)

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

13. Activos disponibles, hash y estado QA

Activos disponibles	Protocolo.pdf (escaneo local del acervo del proyecto, 1 página, legible; identidad verificada por OCR + comparación con fuentes web citadas). Ficha Tecnica.docx / .pdf.
Hash / verificación	Ver MANIFIESTO_SHA256.csv del proyecto (generado por proceso externo posterior a esta entrega).
Estado QA	Ficha documental generada a partir de fuentes secundarias verificables; requiere revisión humana antes de uso clínico formal. Protocolo local abre correctamente y contiene el cuestionario completo (verificado con pypdf).

14. Control de versión

Fecha	2026-08-10
Responsable	Claude — proceso automatizado, requiere revisión humana
Versión de la ficha	1.0